



# 認識心絞痛

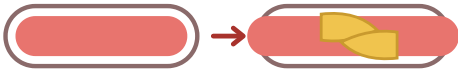
心臟的血管變窄，供血跟不上需求時，胸口就會發出警訊

它是提醒，不是終點——控制得好，可以過正常生活



掃描看電子版

## ① 什麼是心絞痛？



心臟自己也需要血液。冠狀動脈因斑塊變窄時，用力或情緒激動就會供血不足，心肌缺氧而胸悶痛。

## ② 危險因子有哪些？

**可以改變的（治療重點）**

抽菸 高血壓 高血脂 糖尿病  
肥胖 久坐不動 壓力大 睡眠差

**不能改變的**

年齡（男  $\geq 45$ 、女  $\geq 55$ ）、男性、  
早發性冠心病家族史、慢性腎臟病

## ③ 有哪些症狀？

**典型的樣子**

胸口悶、壓、緊，像被大石頭壓住  
可傳到左肩、手臂、下巴、上腹  
用力時出現、休息幾分鐘會緩解

**不典型的樣子（容易被忽略）**

只覺得喘、疲倦、冒冷汗、噁心  
或像胃痛、牙痛、背痛  
女性、糖尿病與長者特別常見

## ④ 醫師會做什麼檢查？

依症狀與風險高低選擇，不是每一項都要做

基本 心电图、抽血（心肌酵素、血脂、血糖、腎功能）、心臟超音波  
看缺氧 運動心电图、核子醫學心肌灌注掃描、運動或藥物負荷心臟超音波  
看血管 電腦斷層冠狀動脈攝影（非侵入性）；**心導管冠狀動脈攝影是確診與治療的黃金標準**

## ⑤ 有哪些治療？

藥物是所有人的基礎；是否放支架或開刀，依血管狹窄程度與症狀決定

**藥物治療（基礎）**

抗血小板藥、statin、  
乙型阻斷劑、硝酸甘油等

**心導管介入（放支架）**

從手腕或鼠蹊部放入導管，  
撐開狹窄處並置放支架

**冠狀動脈繞道手術**

多條或左主幹嚴重阻塞、  
合併糖尿病患者常優先考慮

## ⑥ 我要配合做什麼？

目標值請以醫師為您設定的為準

**壞膽固醇 LDL**  
< 70 mg/dL

**居家血壓**  
< 130 / 80 mmHg

**糖化血色素**  
一般 < 7%

**身體質量指數**  
BMI 18.5~24

運動 每週 150 分鐘中等強度（快走、騎車）；先問醫師可以做到什麼程度  
飲食 少油少鹽少糖、多蔬果全穀與魚；戒菸是所有措施中效益最大的一項  
放過支架者的抗血小板藥，未經醫師同意絕對不可自行停用。

## ⑦ 出現這些情況，立即撥打 119

胸痛持續超過 15~20 分鐘不緩解 | 休息時也發作 | 比平常更痛、更頻繁 | 冒冷汗、喘、快昏倒  
舌下含片用法 坐下含 1 錠；5 分鐘沒改善或更嚴重 → 立刻打 119，不要等含滿 3 錠。  
等救護車時，每 5 分鐘可再含 1 錠，最多共 3 錠。  
切勿與壯陽藥（威而鋼等）併用，可能造成嚴重低血壓。

提醒：心絞痛型態改變（更痛、更久、更頻繁，或休息時發作）代表病情可能惡化，請盡快就醫。

資料來源（查核至 2026-09）：

2024 ESC 慢性冠狀動脈疾病群集指引；2023 AHA/ACC 慢性冠狀動脈疾病指引；

2024 中華民國心臟學會 ASCVD 初級預防指引；2025 台灣血脂管理臨床路徑共識；

2022 台灣高血壓治療指引；台灣糖尿病學會臨床照護指引。本單張供衛教使用，不取代個別診療。

© 2026 林祐騰醫師 編製 本單張僅供臨床衛教使用，未經同意請勿重製、改作或作商業用途。